

Datei: 08_email_schwester.eml

Von	anne.kahl@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Fri, 26 Jun 2026 11:18:00 +0200
Betreff	Doreen will nicht als schwerbehindert abgestempelt werden

Guten Tag,

meine Schwester schwankt. Sie braucht den Ausweis für Schutz und vielleicht später Rente, will aber nicht, dass im Betrieb alle denken, sie kommt nicht zurück. Bitte erklären Sie ihr den Unterschied zwischen Diagnose, GdB und Arbeitsfähigkeit.

Ich fahre sie im Juli zur Chemo. Sie kann danach zwei bis drei Tage kaum die Treppe hoch.

Viele Grüße

Anne Kahl

Datei: 04_therapiekalender.csv

datum	termin	folge	arbeitsausfall
2026-04-04	Operation axilläre Lymphknoten	Drainage und Schmerz	14 Tage
2026-05-12	Chemotherapie Zyklus 1	Übelkeit und Fatigue	7 Tage
2026-06-02	Chemotherapie Zyklus 2	Polyneuropathie Finger	9 Tage
2026-06-23	Chemotherapie Zyklus 3	Lymphödem verstärkt	offen
2026-07-14	Chemotherapie Zyklus 4 geplant	Transport durch Schwester	offen

Mandatsnotiz Onkologie und GdB

1. Mandantin

Mandantin ist Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976, Verkäuferin in einer Buchhandlung in Rostock. Brustkrebs links 2019, Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. GdB 50 wurde damals befristet festgestellt und 2024 nach Ablauf der Heilungsbewährung auf 30 herabgesetzt. Seit Februar 2026 Rezidiv in axillären Lymphknoten, erneute Therapie.

2. Verfahren

Änderungsantrag 18.03.2026. Bescheid 16.06.2026: Gesamt-GdB 40, keine Schwerbehinderteneigenschaft. Begründung: Therapie laufe, Funktionsfolgen noch nicht dauerhaft beurteilbar. Zugang 19.06.2026, Widerspruchsfrist bis 19.07.2026.

3. Auftrag

Widerspruch, vollständige Befundsammlung, Prüfung vorläufiger Nachteilsausgleiche und Abstimmung mit Arbeitsunfähigkeit, Krankengeld, Reha und möglicher Erwerbsminderung. Das Ergebnis offen halten: Es geht um Funktionsfolgen, Rezidivlage und Zeitraum, nicht um eine automatische Dauerfeststellung.

Onkologiebericht

1. Diagnose und Verlauf

Onkologisches Zentrum Rostock, Bericht 10.06.2026. Lokal-regionales Rezidiv Mammakarzinom links, axilläre Lymphknoten, Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ. Therapie: Operation 04.04.2026, adjuvante Chemotherapie ab 12.05.2026, anschließend Bestrahlung und endokrine Therapie geplant.

2. Funktionsfolgen

Lymphödem linker Arm Grad 2, Bewegungseinschränkung Schulter links, ausgeprägte Fatigue, Polyneuropathie an Fingern nach erster Chemogabe, Übelkeit, Schlafstörungen. Ärztliche Empfehlung: keine stehende Vollzeittätigkeit, keine Lasten über 5 kg links, Reha nach Abschluss der Bestrahlung.

3. Prognose

Therapie kurativ intendiert, Rückfallrisiko erhöht. Die Ärztin bittet um Berücksichtigung der erneuten Erkrankung und der gegenwärtigen Therapiebelastung.

Bescheid GdB 40

1. Entscheidung

Das Landesamt stellt einen Gesamt-GdB von 40 ab 18.03.2026 fest. Eine Schwerbehinderteneigenschaft wird nicht anerkannt.

2. Begründung

Die Behörde bewertet Brustkrebserkrankung nach Rezidiv und Therapiebelastung mit Einzel-GdB 40, Lymphödem mit 20 und psychische Belastung mit 10. Eine höhere Bewertung sei wegen noch nicht abgeschlossener Behandlung nicht möglich.

3. Auffälligkeit

Die Behörde verwendet die laufende Therapie zugleich als Anerkennungsgrund und als Begrenzung. Der Onkologiebericht zur Rezidivsituation und die konkreten Einschränkungen im Armgebrauch werden nicht erkennbar vertieft.

Arbeitgebernotiz Buchhandlung

1. Tätigkeit

Doreen Kahl arbeitet normalerweise 30 Wochenstunden im Verkauf, Wareneingang und Veranstaltungsservice. Sie trägt Bücherkisten, räumt Regale, steht an der Kasse und betreut Lesungen.

2. Einschränkungen

Seit Mai 2026 sind Kistenheben, längeres Stehen und Abendveranstaltungen kaum möglich. Kolleginnen übernehmen Wareneingang. Die Arbeitgeberin bietet reduzierte Stunden, kann aber keine reine Sitzkasse garantieren.

3. Bedeutung

Die Notiz zeigt konkrete Teilhabefolgen. Für den GdB ist nicht der Arbeitsplatz allein maßgeblich, aber die Funktionsfolgen werden dadurch greifbar: Armgebrauch, Fatigue, Belastbarkeit, Infektionsschutz und Wege zu Therapie.

Widerspruchsentwurf GdB Krebsrezidiv

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 16.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft ab Antragstellung, hilfsweise erneute Entscheidung nach Beiziehung der vollständigen onkologischen Unterlagen.

2. Begründung

Die Behörde hat Rezidiv, laufende Systemtherapie, Lymphödem, Fatigue und konkrete Funktionsfolgen nicht hinreichend zusammengeführt. Gerade die erneute Erkrankung nach früherer Heilungsbewährung verlangt eine eigenständige Bewertung. Die laufende Therapie darf nicht pauschal gegen die Feststellung verwendet werden, wenn die Teilhabebeeinträchtigung bereits aktuell erheblich ist.

3. Beweismittel

Onkologiebericht, Therapiekalender, Lymphödemtherapie, Arbeitgebernotiz, Fotos Kompressionsversorgung, Befund Psychoonkologie und Reha-Antrag.

Reha, Krankengeld und Rentenbezug

1. Gegenwärtige Leistungen

Die Mandantin bezieht Entgeltfortzahlung, danach voraussichtlich Krankengeld. Onkologische Reha ist nach Bestrahlung geplant. Versicherungsverlauf zeigt 31 Jahre Pflichtbeiträge, Kinderberücksichtigungszeiten und Teilzeitphasen.

2. Rentenberaterliche Prüfung

Kurzfristig steht GdB-Widerspruch und Reha im Vordergrund. Mittelfristig: Nahtlosigkeitsrisiko, Erwerbsminderungsrente nur bei fortbestehender Leistungsminderung, Altersrente schwerbehinderter Menschen wegen Alter noch fern. Die Dokumente sollten dennoch so sortiert werden, dass später keine Therapielücken und Funktionsfolgen verloren gehen.